

Серцево-легенева реанімація

Сценарій (Серцево-легенева реанімація)

Ви – лікар з медицини невідкладних станів, в складі бригади екстреної медичної допомоги прибули на виклик. Ви бачите на підлозі лежить чоловік на вигляд приблизно 55 років, поряд з ним знаходяться люди які намагаються надати першу допомогу.

Об'єктивно: постраждалий лежить на спині, свідомість відсутня, шкірні покриви бліді ціанотичні, при огляді дихання та пульс відсутні. Ви приступаєте до проведення базової серцево-легеневої реанімації.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує вулицю, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.
6	Автоматичний зовнішній дефібрилятор	1 шт.
7	Мішок Амбу з лицьовою маскою	1 шт.
8	Каремат чи ковдра під манекен	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Автоматичний зовнішній дефібрилятор	1 шт.
2	Мішок Амбу з лицьовою маскою	1 шт.



Автоматичний зовнішній дефібрилятор

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановлення контакту з людьми які намагались надати допомогу (привітатись, представитися,	Сказати Доброго дня. Я лікар з

	позначити свою роль). Відповідь на питання лікаря до людей надає екзаменатор.	медицини невідкладних станів, що тут сталося? Скільки минуло часу з моменту як постраждалий знепритомнів?. <i>Відповідь:</i> Це трапилось близько 10 хвилин назад. Він сказав що у нього запаморочилось в голові, після сів на стілець, а хвилину назад впав на підлогу.
1.2	Одягнути медичні рукавички	<i>Виконати</i>
2. Виконання навички		
2.1	Провести швидкий огляд пацієнта	<i>Виконати</i>
2.2	Визначити місце прикладання рук для проведення закритого непрямого серця.	<i>Виконати</i>
2.3	Розпочинати СЛР у дорослих пацієнтів з непрямого масажу серця з мінімізацією перерв між компресіями, незалежно від причини зупинки кровообігу.	<i>Виконати</i>
2.4	Забезпечити прохідність дихальних шляхів (прийом П.Сафара) доки не буде досягнута ефективна вентиляція, із розширенням заходів до застосування мішка Амбу та лицьової маски при цьому необхідно призупиняти компресії під час вентиляції, використовуючи співвідношення компресія/вентиляція 30:2.	<i>Виконати</i>
2.5	СЛР продовжується, доки стан пацієнта не стабілізується або буде доступний дефібрилятор та накладені електроди	<i>Виконати</i>
2.6	Виконується дефібриляція	<i>Сказати:</i> Застосування дефібрилятора базується на ранньому аналізі ритму зупинки кровообігу з наступним проведенням дефібриляційного розряду.
2.7	СЛР продовжується ще 2 хвилини. Після з'являється пульс та дихання. При правильному виконанні СЛР, про відновлення пульсу та дихання каже екзаменатор.	<i>Виконувати:</i> до відновлення дихальної та серцево-судинної функції
2.8	Зняти рукавиці.	<i>Виконати</i>
3. Встановити попередній діагноз (визначити стан пацієнта)		
3.1	Стан клінічної смерті	<i>Сказати</i>

4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після вдалого проведення СЛР проводити контроль гемодинамічних показників та як найшвидше доправити до спеціалізованого закладу.	<i>Сказати</i>